

# IV CONCURSO INTERNACIONAL EN DERECHO MÉDICO, BIOÉTICA Y BIODERECHO

CASO HIPOTÉTICO

## CASO VALENTINA Y AMALIA VS. ESTADO DE AVELIA



*El Derecho Humano Autónomo al Cuidado, Enfoque de Género,  
Nuevas Tecnologías y las Fronteras de la Solidaridad Familiar*

Coordinado por:  
**JHONY JAVIER ÑUSTES D.**  
**MAICOL ANDRES RODRIGUEZ B.**

**COLEGIO DE ABOGADOS EN DERECHO MÉDICO**  
Tribunal Internacional del Derecho a la Salud — Sede Bogotá, Colombia  
2026

## TABLA DE CONTENIDOS

|                                                                                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| TABLA DE CONTENIDOS .....                                                                  | 2                                    |
| 1. Antecedentes y contexto del Estado de Avelia.....                                       | 3                                    |
| 2. El contexto familiar y la patología de Amalia.....                                      | 3                                    |
| 3. El conflicto bioético: el «Proyecto Mnemósine» y el síndrome del cuidador quemado ..... | 4                                    |
| 4. El tránsito jurisprudencial interno.....                                                | 5                                    |
| 5. La demanda internacional ante el Tribunal Internacional del Derecho a la Salud .....    | 6                                    |
| 5.1. Derechos invocados bajo el Estatuto de Barcelona.....                                 | 7                                    |
| 5.2. Normas internacionales de derechos humanos.....                                       | 7                                    |
| 5.3. Jurisprudencia interamericana (derecho aplicable, art. 20 EB) ...                     | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 5.4. Jurisprudencia del TEDH (derecho comparado persuasivo) .....                          | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 5.5. Derecho comparado persuasivo: la Corte Constitucional de Colombia.....                | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 5.6. Síntesis de los argumentos de la parte ACCIONANTE (Víctimas) .....                    | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 5.7. Síntesis de los argumentos del ESTADO de Avelia .....                                 | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 5.8. Problemas jurídicos (ejes de debate).....                                             | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 6. Posibles aclaraciones y precisiones (anticipadas por la organización) ..                | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |

## 1. Antecedentes y contexto del Estado de Avelia

---

- A. El Estado de Avelia es una república unitaria, social y democrática de derecho, del continente americano, con 45 millones de habitantes y un sistema de salud mixto en el que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) administran recursos parafiscales bajo planes de beneficios estrictos.
- B. Avelia ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en 1982 y el PIDESC en 1978, y es Estado Parte fundador del Estatuto de Barcelona del Tribunal Internacional del Derecho a la Salud, con depósito oportuno de su instrumento de ratificación.
- C. Su Constitución protege la vida (art. 11) y la salud integral (art. 49), pero **Avelia carece de un Sistema Nacional Integral de Cuidados**. Su código civil y sus políticas sanitarias han tratado el cuidado de personas dependientes como obligación privada y exclusiva del núcleo familiar, sobre la base de un “principio absoluto de solidaridad familiar”.
- D. Según el Censo Nacional de Avelia 2023, el 74% del cuidado no remunerado de personas dependientes recae sobre mujeres; el tiempo medio de cuidado intensivo supera las 50 horas semanales. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo estima el valor económico del trabajo de cuidado no remunerado en cerca del 19% del PIB de Avelia, cifra que el Estado reconoce en sus cuentas satélite pero no retribuye.
- E. En 2021, el Congreso de Avelia archivó por segunda vez un “Proyecto de Ley de Cuidados” que proponía servicios de respiro, asistencia domiciliaria y seguridad social para cuidadores. El Ministerio de Hacienda emitió concepto de inviabilidad fiscal. Desde entonces no se ha tramitado iniciativa alguna.
- F. La Resolución 512 del Ministerio de Salud de Avelia excluye expresamente del Plan de Beneficios en Salud los “servicios de acompañamiento social, cuidador y apoyo doméstico”, salvo “ensayos o protocolos especiales debidamente autorizados” —excepción cuyo alcance no ha sido reglamentado—.

## 2. El contexto familiar y la patología de Amalia

---

- A. **Amalia**, de 73 años, exprofesora de literatura de educación pública, viuda, habitante de la capital. En enero de 2023 fue diagnosticada con una variante agresiva de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) asociada a demencia frontotemporal, que la sumió en dependencia total para todas las actividades

- básicas e instrumentales de la vida diaria (alimentación, higiene, traslados y soporte ventilatorio nocturno).
- B. Su única red de apoyo es su hija **Valentina**, de 43 años, ingeniera aeroespacial y, hasta 2024, directora de proyectos en una multinacional tecnológica. Ante la ausencia de asistencia domiciliaria en el plan de beneficios, Valentina redujo su jornada y, en octubre de 2024, renunció a su empleo para asumir el cuidado directo no remunerado de su madre.
  - C. Al renunciar, Valentina perdió un ingreso anual significativo, su trayectoria profesional y su afiliación contributiva. Pasó al régimen subsidiado. No cotiza para pensión desde 2024, lo que compromete su futura vejez —reproduciendo, una generación después, la misma desprotección que hoy sufre Amalia—.
  - D. Amalia y Valentina no cuentan con otros familiares; el padre de Valentina falleció en 2019. No existen en su localidad centros de día públicos ni programas municipales de respiro. Las cotizaciones para un cuidador privado por 16 horas diarias superan diez veces el subsidio que recibe el hogar.
  - E. Pese a la demencia frontotemporal, los informes neuropsicológicos documentan ventanas de lucidez en las que Amalia conserva capacidad para expresar su voluntad sobre su propio tratamiento; reiteró por escrito, ante notario y en presencia de su médica tratante, su deseo de acceder al implante y de no ser una carga destructiva para su hija.

### 3. El conflicto bioético: el «Proyecto Mnemósine» y el síndrome del cuidador quemado

---

- A. En mayo de 2025, el Instituto de Neurotecnología de Avelia (economía mixta, siendo más pública que privada) preseleccionó a Amalia para el protocolo experimental **“Proyecto Mnemósine”**: implantación de una interfaz cerebro-computador (BCI) con nanotransmisores biológicos para restaurar la autonomía motora fina y la comunicación cognitiva en ELA avanzada.
- B. En un momento de lucidez, ejerciendo su autonomía y su derecho al goce de los beneficios del progreso científico, Amalia otorgó consentimiento informado. La Junta Médica fijó una condición clínica estricta: para evitar el fallo del implante o una neuroinflamación fatal, el paciente requiere un protocolo de estimulación postoperatoria física y cognitiva neuroespecífica de **16 horas diarias en el entorno doméstico, durante un mínimo de 18 meses**.

- C. Para finales de 2025, Valentina ya presentaba un cuadro severo de **Síndrome del Cuidador Quemado** —depresión clínica, fibromialgia reactiva por sobreesfuerzo físico y aislamiento social crónico—, y manifestó a la Junta que le era fáctica, física y emocionalmente imposible asumir el nuevo protocolo sin colapsar; advirtió que su salud psíquica y su dignidad estaban anuladas.
- D. Valentina y Amalia solicitaron formalmente a la EPS un “**Servicio de Asistencia Personal y de Cuidado Domiciliario Profesional**” por **16 horas diarias** para viabilizar el tratamiento. La EPS negó la solicitud porque: (1) el cuidador es un servicio de acompañamiento social excluido del plan; (2) la familia debe absorber la carga por solidaridad familiar; y (3) Valentina, sin otros hijos a cargo ni empleo actual, posee “disponibilidad de tiempo legal” para sus deberes filiales.
- E. El comité científico del Instituto fijó como fecha límite de elegibilidad de Amalia para el implante **a finales de 2026**; superada esa ventana, el avance de la ELA haría inviable y peligroso el procedimiento. El tiempo, por tanto, es un elemento jurídico del caso.
- F. El comité advirtió una doble tensión: por un lado, el principio de *beneficencia* y la autonomía de Amalia favorecen el implante; por otro, el principio de *no maleficencia* se proyecta también sobre Valentina, pues encomendar a una cuidadora clínicamente colapsada un protocolo de 16 horas diarias podría producir daño a ambas y comprometer el éxito del implante. El comité recomendó “resolver la barrera de cuidado antes de operar”, sin definir quién debe financiarla.
- G. La parte accionante sostiene que condicionar un tratamiento de vanguardia a 16 horas diarias de trabajo gratuito de la hija convierte a Valentina en un “insumo terapéutico” del sistema, contrario a la dignidad humana y a la prohibición de instrumentalizar a la persona (art. 17 del Estatuto de Barcelona; principio kantiano recogido por la bioética contemporánea).

#### 4. El tránsito jurisprudencial interno

---

- A. Valentina, en nombre propio y como representante legal de Amalia, interpuso acción de tutela contra la EPS y el Ministerio de Salud, alegando la violación del derecho a la salud integral, a la vida digna y al cuidado en su triple dimensión (ser cuidada —Amalia—, cuidar en igualdad —Valentina— y autocuidado —ambas—). Invocó como estándar convencional obligatorio la **Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte IDH**, que conceptualizó el cuidado como derecho humano autónomo e interdependiente.



- B. El 14 de enero de 2026, la Corte Suprema de Avelia negó definitivamente el amparo. Resolvió que, aunque la OC-31/25 es “criterio interpretativo relevante”, el derecho al cuidado en Avelia es un “derecho programático en proceso de construcción jurídica abstracta” que no puede traducirse en obligación financiera directa sin ley expresa del Congreso. Afirmó:

*“El principio de solidaridad familiar obliga a la progenie a postergar sus proyectos individuales en aras de la subsistencia de sus ascendientes; obligar al Estado a sustituir las redes familiares desestructuraría la sostenibilidad fiscal del sistema sanitario”.*

- C. Un juzgado de tutela había concedido parcialmente el amparo en noviembre de 2025, ordenando a la EPS un cuidador por 8 horas; la decisión fue revocada en segunda instancia y luego por la Corte Suprema, que acogió el argumento de sostenibilidad fiscal y reserva de ley.
- D. Un magistrado disidente de la Corte Suprema sostuvo que la OC-31/25 es vinculante por vía del control de convencionalidad, que la solidaridad familiar no puede ser “absoluta” cuando aniquila la salud del cuidador, y que la inacción legislativa no puede oponerse como excusa frente a un derecho exigible. Este salvamento es parte del expediente.
- E. Con la decisión de la Corte Suprema, las accionantes agotaron la jurisdicción interna sin obtener una respuesta efectiva, habilitando la vía internacional.

## 5. La demanda internacional ante el Tribunal Internacional del Derecho a la Salud

---

1. Dada la crisis médica de Amalia (cuyo acceso al implante expira a finales de 2026) y el deterioro de Valentina, organizaciones de derechos humanos y de género elevaron el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho a la Salud, sede Bogotá. El Tribunal admitió la demanda por presunta violación sistemática del Estatuto de Barcelona; Avelia contestó alegando falta de competencia para imponer prestaciones económicas sociales no reguladas y defendió su margen de discrecionalidad sanitaria.
2. Como medida cautelar de oficio (arts. 1 y 22 EB), el Tribunal ordenó a Avelia: (i) garantizar provisionalmente apoyo de cuidado domiciliario suficiente para no truncar la ventana terapéutica de Amalia; (ii) asegurar atención inmediata en salud física y mental para Valentina; y (iii) abstenerse de cualquier medida regresiva mientras se resuelve el fondo.

3. El Tribunal fijó audiencia pública de fondo con práctica de un dictamen pericial (art. 49 del Reglamento) sobre el impacto neuropsicológico del Síndrome del Cuidador Quemado y la viabilidad clínica del implante BCI en entornos familiares de alta tensión, audiencia a celebrarse en el mes de octubre de 2026 en la ciudad de Bogotá.

### 5.1. Derechos invocados bajo el Estatuto de Barcelona

- **Deber de respetar los DD.HH. y de adoptar disposiciones de derecho interno — Arts. 2 y 5 EB:** obligación de adecuar el ordenamiento para hacer efectivo el derecho al cuidado.
- **Prohibición de tratos inhumanos o degradantes — Art. 6 EB:** la imposición de cuidado destructivo a una cuidadora colapsada.
- **Derecho a la vida y vida digna — Art. 8 EB:** acceso oportuno a servicios de salud; prohibición de que grupos vulnerables soporten carga sanitaria excesiva (art. 8.5 EB).
- **Derecho a la integridad personal — Art. 10 EB:** integridad física, psíquica y moral de Valentina y Amalia.
- **Derecho a la salud — Art. 11 EB:** disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad; salud en el trabajo; talento humano en salud (art. 24 EB).
- **Goce de los beneficios del progreso científico — Art. 11.18 EB:** acceso de Amalia a la innovación biomédica (BCI).
- **Igualdad y no discriminación — Arts. 11.2.a y 21 EB:** discriminación estructural por género en la distribución del cuidado.
- **Buen ejercicio de la bioética — Art. 17 EB:** dignidad, autonomía, beneficencia, no maleficencia; prohibición de instrumentalizar a la persona.
- **Desarrollo progresivo — Art. 24 EB:** deber de medidas deliberadas y no regresividad, dentro del máximo de recursos disponibles.

### 5.2. Normas internacionales de derechos humanos

- **CADH — arts. 4, 5, 7, 11, 17, 19, 24 y 26** en relación con el art. 1.1 (base del derecho autónomo al cuidado, OC-31/25).
- **OC-31/25 de la Corte IDH (7 de agosto de 2025) —** primer reconocimiento internacional del cuidado como derecho humano autónomo (ser cuidado, cuidar, autocuidado); deberes estatales de abstención, organización del aparato estatal y adopción/supresión de normas; principio de corresponsabilidad y de solidaridad.

- **PIDESC** — arts. 2.1, 3, 9, 10 y 12 (no discriminación, seguridad social, protección a la familia, salud).
- **CEDAW** — arts. 5 y 11 (responsabilidad común de hombres y mujeres en el cuidado; eliminación de estereotipos de género); Recomendación General 27 (mujeres mayores).
- **CDPD** — arts. 19 (vida independiente y en comunidad), 25 (salud), 26 (habilitación/rehabilitación) y 28 (protección social).
- **Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores** — arts. 12 (cuidados de largo plazo) y 19 (salud).
- **OIT** — Convenio 156 (responsabilidades familiares) y Convenio 189 (trabajo doméstico).

